



1

55. ÅRGANG | 01 • 2018

ARTIKEL

PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK TIDSSKRIFT
FORLAGET SKOLEPSYKOLOGI • PÆDAGOGISKE PSYKOLOGERS FORENING

Tema

Angst

PPT nr. 1-2018

Angstlidelser hos børn

Af Mikael Thastum

Angstlidelser hos børn



Artiklen gennemgår, hvordan der skelnes mellem normal og patologisk angst, hvad vi ved om, hvorfor børn og unge udvikler angst, samt de mest almindelige angstlidelser hos børn. Formålet med artiklen er at give en kort og praksisnær oversigt over viden om angstlidelser hos børn.

Af Mikael Thastum, professor og leder af Center for Psykologisk Behandling til Børn og Unge (CEBU), Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

Angst, frygt og bekymringer er en normal del af tilværelsen og er nødvendige for vores overlevelse. Frygt beskytter os i situationer, hvor vi er truede, og får os til at passe på os selv. Hvis vi ikke mærkede frygt, ville vi ikke reagere tilstrækkeligt hurtigt i situationer, der er til fare for os, og dermed risikere at komme til skade. Også bekymringer er nyttige, hvis de ikke tager overhånd. F.eks. kan en moderat bekymring for, om man kan bestå eksamen motivere en til at sørge for at være godt forberedt.

Hos børn er frygt, angst og bekymringer naturligt forekommende i bestemte perioder af opvæksten. Spædbarnets angst er rettet mod umiddelbare konkrete farer som høje lyde og at blive tabt. Angst for adskillelse fra de vigtigste omsorgspersoner og angst for fremmede vil typisk vise sig hos børn fra 6-9 måneders alderen og klinge af i 1-2 års alderen. Separationsangsten tjener til at holde barnet i nærheden af dets beskyttende omsorgspersoner. Efterhånden som barnet bliver ældre og begynder at udforske omgivelserne,

kan der udvikles angst for f.eks. dyr som hunde og insekter, for mørke og for vand, samt angst for det overnaturlige som spøgelser og uhyrer. Angsten i denne alder skyldes, at barnet, selv om det nu er mere selvstændigt, stadig er relativt forsvarsløst over for trusler. Mange børn har også i perioder ritualer eller handlinger, som skal gøres på bestemte måder eller gentages – f.eks. at tingene på værelset skal arrangeres på en ganske bestemt måde. I skolealderen bliver den sociale position blandt jævnaldrende vigtigere, og bekymringer for at være anderledes end andre og hvad andre tænker om én bliver derfor mere fremtrædende og kulminerer i teenagealderen, hvor mange unge bliver meget optaget af eget udseende og opførsel.

I moderate doser er angst og bekymringer altså adaptive og tjener til undgåelse af farer. For meget angst og bekymring kan imidlertid have en negativ effekt på barnets dagligdag og funktion. Da angst optræder i grader og på et kontinuum fra mild og forbigående til svær og vedholdende, og da

angst er en del af barnets typiske udvikling, kan det være vanskeligt at differentiere mellem normal og patologisk angst i barnealderen. Normal angst er typisk forbigående og forventelig og forårsager relativt lidt funktionsforstyrrelse for barnet eller den unge. Den skyldes ofte noget bestemt, barnet har været udsat for (f.eks. tordenvejr, at skulle holde et oplæg på skolen, mørke), men den går over igen, når situationen er overstået, eller når barnet har lært, at frygten var ubegrundet. De diagnostiske kriterier for angstlidelser er beskrevet i DSM5 [1] og ICD10 [2], men en tommelfingerregel for, hvornår et barn har brug for hjælp til sin angst, er, når barnet oplever ikke-alderssvarende angst og frygt i situationer, som ikke udgør en reel trussel eller fare, og i en grad så angsten påvirker barnets daglige aktiviteter eller barnets evne til at indgå i alderssvarende aktiviteter. I en vurdering af om et barn kunne have gavn af at få hjælp til sin angst, bør det derfor undersøges, 1) på hvilke og hvor mange områder angsten griber ind i barnets funktion (f.eks. hjemme, i skolen, i forhold til jævnaldrende), 2) hvor ofte angsten hæmmer barnet, og 3) hvor intenst angsten opleves af barnet.

Hvor mange børn har angstproblemer?

Vi ved nu, at angstlidelser udgør den hyppigst forekommende psykiske lidelse hos børn og unge. Internationale epidemiologiske undersøgelser tyder på, at livstidsprævalensen for angstlidelser hos børn og unge i vestlige lande er 15 % - 20 % [3], og at på et givet tidspunkt vil 2,5 % - 5 % børn og unge

kunne diagnosticeres med en angstlidelse [4], hvilket svarer til gennemsnitligt et barn i hver skoleklasse. I Danmark anslår Sundhedsstyrelsen, at 40-48.000 børn og unge i alderen 6-18 år lider af behandlingskrævende angst [5]. Omkostningerne ved angst for barnet, familien og samfundet er store, både på kort og på langt sigt. Angst nedsætter barnets funktionsniveau i samme grad som andre mentale lidelser som fx depression [6], og angst påvirker barnets familie, forhold til jævnaldrende, skolegang, og fritidsaktiviteter i en negativ retning. Børn med angstlidelser er både dyre for samfundet og for familierne selv. Udgifterne til et barn med angst er omkring 20 gange større end til et barn i al almindelighed [7], og Sundhedsstyrelsen har vist, at angst er den dyreste enkeltstående lidelse i Danmark, også når somatiske lidelser er medregnet [8]. Angstlidelser har ofte et kronisk forløb. Halvdelen af de børn og unge, der har en angstlidelse, har haft angst i mere end 8 år, og for flere end halvdelen af alle voksne med angstlidelser startede angstproblemerne allerede i barnealderen [9]. Der er ligeledes stor risiko for, at børn med ubehandlede angstlidelser vil vedblive med at have angst eller vil udvikle andre problemer som depression eller misbrug senere i livet.

Paradoksalt nok er det kun få børn med angstlidelser, der får tilbud om hjælp til deres angst, og der er kun få offentlige tilbud til børn med angstlidelser i Danmark. Der kan være flere årsager hertil. Tidligere blev angst hos børn betragtet som en mild forstyrrelse, der nok ville gå over af sig selv, ef-

terhånden som barnet blev ældre. Mange symptomer ved angstlidelser, som f.eks. ondt i maven og undgåelsesadfærd, er usynlige for andre og kan derfor gå ubemærket hen. Angste børn forstyrrer ikke deres omgivelser på samme måde som børn med f.eks. adfærdsforstyrrelser. Forældre kan tænke, at barnets angst er en del af barnets personlighed, som der ikke kan gøres noget ved.

Hvorfor udvikler børn angstlidelser?

Gener og temperament.

Børn med angstlidelser har større sandsynlighed for at have en forælder med en angstlidelse end andre børn, og forældre med angstlidelser har større sandsynlighed for, at deres børn også har en angstlidelse end andre forældre. Angstlidelser har således en tendens til at gå igen i familier. Tvillingestudier viser, at der er en arvelig komponent, men også at miljømæssige faktorer spiller en mindst lige så stor en rolle for, om et barn udvikler angst. Nye forskning tyder på, at generne og miljøet interagerer. Et eksempel på denne mekanisme er en undersøgelse, der viste, at en særlig genkomposition forudsagde generthed og adfærdshæmning hos børn, men kun hvis barnet var i en familie, der havde et lavt niveau af social kontakt med andre [10]. Genetikstudierne viser således, at miljøet spiller en afgørende rolle for, hvordan de genetiske dispositioner kommer til udtryk.

Børn reagerer fra fødslen forskelligt på nye og uventede begivenheder, og omkring 15 - 20 % af alle børn fødes

med et temperament, der gør dem særlig følsomme for stimulation i spædbarnsalderen, en tendens til at være ængstelige som småbørn, og en tendens til at være sky og generte i børnehavealderen. Nogle studier tyder på, at denne temperamentsmæssige stil, ofte kaldet adfærdshæmning, er en risikofaktor for senere udvikling af angstlidelser, især socialfobi. De omgivelser, barnet vokser op i, kan enten fremme eller hæmme denne udvikling. Hvis barnet under opvæksten lærer at tackle stress og angst på en fornuftig måde, formindskes risikoen for at udvikle en angstlidelse. Hvis barnet omvendt bliver overdrevet beskyttet, kan det blive forhindret i at konfrontere dets frygt og derved blive forhindret i at lære, at frygten er urealistisk eller ubegrundet. Adfærdshæmning kan imidlertid også anskues som en angstproblematik i sig selv, som imidlertid endnu ikke er blevet diagnosticeret, fordi barnet endnu er for lille til, at symptomerne påvirker barnets og forældrenes livskvalitet tilstrækkeligt. Først i forbindelse med at barnet f.eks. starter i skole, bliver barnets vanskeligheder åbenlyse og skaber problemer for barnet. Ud fra denne forståelse ville det være relevant at lave forebyggende forældreprogrammer for små børn, der er adfærdshæmmede [11].

Forældrenes betydning

Overkontrol

Forældres adfærd kan på forskellige måder være med til at udvikle eller vedligeholde et barns angst. Forældre til angste børn har vist sig i højere grad end forældre til ikke-angste børn at være kontrollerende i barnets liv og

at overbeskytte barnet, samt i mindre grad at lade barnet selv tage beslutninger om områder af barnets liv (fx hvilket tøj det skal tage på, hvilke venner det vil have mv.) [12]. Forældres overdrevne regulering af barnets adfærd samt manglende støtte til barnets udvikling af selvstændighed kan give barnet en opfattelse af, at verden er farlig og ukontrollabel, samt modvirke at barnet udvikler en følelse af selvkompetence og mestring og dermed teoretisk antages at medvirke til udvikling af samt vedligeholdelse af et barns angstlidelse. Selvom forskningen ret entydigt viser denne sammenhæng mellem forældres overkontrol og angst hos børn, er årsagssammenhængen dog ikke afklaret. Således kunne man forestille sig, at et i forvejen ængsteligt barns adfærd udløser en overbeskyttende og overkontrollerende adfærd fra forældrene. Uafhængigt af årsagsforholdet bidrager overkontrollerende forældreadfærd dog til vedligeholdelsen af barnets angst.

Forældre, der i bedste mening er meget regulerende overfor barnet, altså fortæller barnet præcist hvad det skal gøre, hvordan det skal opføre sig, og hvad det skal sige i angstprovokerende situationer, eller som gør alle de ting for barnet, som det ikke selv tør, kan således uafvidende give barnet et signal om, at verden er farlig og ukontrollabel, forhindre at barnet udvikler tro på at det selv kan, og dermed støtte op omkring barnets tendens til undgåelse.

Børn med angst søger ofte konstant beroligelse fra deres forældre, og forsikringer om, at det farlige ikke vil ske. Gentagne velmenende forsikringer og opmærksomhed fra forældrene har

imidlertid sjældent effekt på et barn med en angstlidelse, snarere kan forsikringerne bidrage til, at barnet lærer, at det ikke selv kan klare vanskelige situationer uden hjælp fra forældrene. Samtidig giver forsikringerne og beroligelsen barnet en positiv opmærksomhed, som er med til at øge sandsynligheden for, at barnet vil blive ved med at spørge.

Modelindlæring

Forældre er modeller for deres børn, og børn kopierer deres forældres måde at forholde sig til verden på. Grundet det store overlap, der er mellem angst hos forældre og børn, er det sandsynligt, at mange børn med angst jævnlige oplever ængstelig adfærd og tankemønstre i forældrene [13]. Hvis et barn ser, at dets mor er bange for edderkopper og derfor undgår rum med edderkopper, eller at hun føler sig utilpas og ængstelig i sociale situationer og derfor bliver tavs og indelukket sammen med andre, er der stor sandsynlighed for, at barnet lærer, at der er grund til at frygte disse situationer, og at løsningen er at undgå dem. En undersøgelse, hvor mødre med socialfobi skulle samtale med en fremmed, og hvor denne samtale blev overværet af deres 10 måneder gamle spædbarn, viste, at barnet 4 måneder efter i højere grad undgik fremmede, end børn med mødre uden socialfobi der havde deltaget i samme eksperiment. Forskellen var større, hvis barnet samtidig havde et ængsteligt temperament [14]. Konklusionen her er ikke, at forældre er skyld i, at deres barn udvikler angst, men at især forældre, der selv er ængstelige, med fordel bevidst kan arbejde med deres ad-

færd, så de ikke overfører deres ængstelighed til barnet.

Forældre til børn med angst vurderer ofte, at barnet er særlig skrøbeligt og sky, at disse træk hos barnet er vedvarende og uforanderlige, samt at de selv ikke er i stand til at hjælpe barnet tilstrækkeligt [15]. Sådanne forældre-kognitioner kan være med til at vedligeholde barnets undgåelsesadfærd, samt måske forhindre at barnet får hjælp til sin angst.

Ugunstige opvækstbetingelser og negative livsbegivenheder

De få studier, der er lavet indtil nu, tyder på, at der er sammenhæng mellem udvikling af angstlidelser hos børn og lav socioøkonomiske status, samt dysfunktion i familien såsom fysisk og seksuelt misbrug. Disse er dog også risikofaktorer for udvikling af mange andre psykopatologiske tilstande hos børn.

Noget forskning antyder, at negative livsbegivenheder, som fx at forældrene bliver skilt, dødsfald i familien, mobning i skolen, at blive bidt af en hund, eller at have været med i et trafikuheld, kan være med til at udløse angstlidelser hos børn. En angstlidelse hos et barn kan dog også omvendt være med til at udløse ubehagelige og stressende situationer. Et barn, der er meget ængsteligt i sociale sammenhænge, kan på grund af dets hæmmede adfærd være i større risiko for at blive drillet eller overset af andre børn i skolen, og en 12-årig der ikke tør sove på sit eget værelse, men vil ligge i sengen hos forældrene og sove, og heller ikke vil med skoleudflugter, kan have svært ved at etablere venskaber og måske blive socialt isoleret.

Barnets urealistiske tanker og opfattelser
Ligesom for voksne med angstlidelser har børn med angstlidelser vist sig at have en særlig måde at opfatte og tolke både omgivelserne og dem selv på, som spiller en væsentlig rolle i at holde angsten vedlige og muligvis også i udviklingen af angstlidelser.

Børn med angst er således særlig opmærksomme på muligt truende eller farlige situationer i omgivelserne. Et barn med angst for hunde vil således have en tendens til konstant at scanne omgivelserne for mulige hunde, og et barn med socialfobi vil være meget opmærksom på kammeraternes ansigtsudtryk og især lægge mærke til og fokusere på udtryk, der ser ud til at være uvenlige eller vrede. Mange børn med angst er også overdrevent opmærksomme på deres kropslige fornemmelser, som de kan tolke som smerter, ubehag eller tegn på sygdom. Denne selektive opmærksomhed hjælper barnet med at undgå mulige ubehagelige situationer og kan derfor være til fordel for barnet på kort sigt. På længere sigt er den imidlertid med til at vedligeholde og forøge angsten, fordi den forhindrer barnet i en mere realistisk opfattelse af omverdenen og dem selv og samtidig øger barnets undgåelsesadfærd.

Ikke alene har børn med angst en selektiv opmærksomhed, men de har også en tendens til at tolke flertydige hændelser som faretruende. Hvis et barn med angst fx ser en gruppe børn i skolegården le sammen af noget, vil der være sandsynlighed for, at det tolker det som at børnene ler hånligt af barnet, i stedet for at tolke det neutralt, som f.eks. at børnene ler sammen

af en vittighed. Børn med angst fokuserer i høj grad på de mulige farer i verden og har tillige en tendens til i særlig grad at huske dårlige ting, der er sket i fortiden, i stedet for de gode ting der også er sket [4, 16].

Denne overdrevne opmærksomhed, fortolkning af og hukommelse i forhold til negative ting, der karakteriser børn med angst, gør, at de hyppigt tænker, at begivenheder er meget værre, end de realistisk set er, samt at de ruger over de negative ting, de oplever, der er sket, og forventer det værste af fremtiden.

Det er muligt, at denne selektive opmærksomhed og fortolkning indlæres af barnet gennem opvæksten. Børn oplever til stadighed en mængde nye og ofte flertydige situationer, og de søger at skabe forståelse og mening ved at iagttage, hvordan signifikante andre i deres omgivelser reagerer på disse situationer. Forældre og andre voksne omkring barnet viser barnet, både gennem ansigtsudtryk, kropslige reaktioner og hvad de siger, hvordan dagligdags situationer skal fortolkes og reageres på. Hvis de primære voksne omkring barnet fortolker dagligdags situationer som truende i højere grad end fx neutrale, vil barnet over tid trænes op i en tilsvarende selektiv ængstelig opmærksomhed og fortolkning.

Barnets undgåelsesadfærd

Det angste barns tænkning forstærkes og holdes vedlige af, at børn med angst typisk vælger at undgå de situationer som de oplever som truende. Undgåelse er et helt centralt træk ved angste børns adfærd, som har den negative effekt, at det bliver umuligt for barnet at

opdage, at dets negative tanker er urealistiske. Ved at undgå alt skræmmende forhindres barnet i at opdage, at tingene måske ikke er så slemme som det tror, og at det ikke nødvendigvis vil komme til skade.

Opsummerende om årsager til udvikling af angstlidelser hos børn

Vi er endnu langt fra udtømmende at forstå, hvorfor nogle børn udvikler en angstlidelse. Der er dog generel enighed om nogle typiske risikofaktorer og deres indbyrdes sammenhæng. En hæmmet temperamentsmæssig disposition ses som en central komponent, som udløser og interagerer med andre risikofaktorer. Et vigtigt kendetegn ved denne temperamentsmæssige stil, som formentlig er central for udviklingen af en angstlidelse, er en undgående mestringsstil, altså at barnet helt undgår eller hurtigt trækker sig fra muligt truende situationer. Hvis barnets omsorgspersoner er karakteriseret ved en trusselorienteret tænkning, kan dette være med til at øge barnets undgåelsesadfærd, som igen kan forstærke omsorgspersonernes overkontrol. Som barnet vokser op, kan det blive mødt med både direkte og indirekte information om, at omgivelserne er farlige, og hvis barnet i forvejen har et hæmmet temperament, kan det være mere tilbøjeligt til at blive påvirket af denne information. Hvis barnet desuden vokser op i belastende familieforhold, får det negative oplevelser, som yderligere bekræfter, at verden er truende og farlig. Blandt de unikke oplevelser det enkelte barn gennem opvæksten får både i og uden for familien, vil nogle indeholde information om trusler

og farer. Disse oplevelser filtreres imidlertid gennem det enkelte barns særlige personlighed og måde at opfatte verden på, og det i forvejen ængstelige barn vil i særlig grad blive påvirket af negative oplevelser. Vejen fra temperament til angstlidelse og arten og sværhedsgraden af en angstlidelse vil være bestemt af et komplekst samspil mellem disse faktorer.

Hvordan påvirker angsten krop, tænkning og adfærd?

Angst kan have mange forskellige former og indhold, og ikke to børn med angst er ens. Der er dog nogle fælles træk ved alle slags angst. Når et barn oplever eller forventer, at noget farligt skal ske og bliver angst, påvirkes det på 3 måder: ved kropslige symptomer, i måden barnet tænker på, og i barnets adfærd.

For at forberede barnet på at reagere på en faretruende situation, sender hjernen besked til *kroppen* om at gøre sig klar til enten at kæmpe imod faren eller at flygte fra den. Dette kaldes kamp/flugt mekanismen. Hjernen sender hormoner ud i kroppen, som bl.a. øger muskelkraften, pulsen og vejrtrækningen. Barnet kan føle sig varm, svedig og tør i munden, og fordi fordøjelsessystemet går delvist i dvale, kan barnet få mavepine og kvalme. De anspændte muskler kan give smerter og rysten i kroppen. Efterfølgende kan barnet blive træt og udmattet.

Barnets *tanker* vil være mere eller mindre konstant rettet mod mulige farer og trusler, f.eks. at noget skulle ske med dets forældre, eller at andre vil grine af det. Det bliver derfor svært for barnet at koncentrere sig om alminde-

lige dagligdags aktiviteter. Barnet laver typisk 3 såkaldte tankefejl: 1) Det overvurderer, hvor sandsynligt det er, at noget dårligt vil ske (sandsynligheden). 2) Det overvurderer, hvor slemt det ville være, hvis det dårlige skulle ske (konsekvensen). 3) Det undervurderer dets egne evner til at klare situationen, hvis det dårlige skulle ske (mestringsevnen).

Typisk vil barnet føle trang til at undslippe eller undgå det, det er bange for. *Undgåelsesadfærd* er et af de mest karakteristiske træk ved angstlidelser. Det kan være åbenlys undgåelse, som f.eks. at lade være med tage med på lejrskole, hvis man er bange for at kammeraterne tænker dårligt om en, eller mere skjult undgåelse, som f.eks. altid at vaske hænder mindst 5 gange, fordi man er bange for, at der ellers vil ske en katastrofe. Det er primært undgåelsesadfærden, som får angsten til at blive ved med at være til stede, og som holder angsten i live. Undgåelse fører til hurtig nedgang i angsten, således at undgåelse fungerer som en slags umiddelbar belønning. Dette betyder, at næste gang barnet konfronteres med en angstprovokerende situation, vil det have endnu mere tendens til at undgå situationen, således at dagligdags aktiviteter bliver tiltagende vanskeligere at gennemføre.

Forskellige former for angst

Nogle børn er kun bange for en enkelt eller få ting, som eksempelvis hunde eller at komme til tandlæge. Andre børn er bange for, at der skal ske noget med dem selv eller deres forældre, hvis de ikke er sammen, atter andre bliver bange i sociale situationer med andre

mennesker eller bekymrer sig om alle mulige farlige ting, der kunne ske. Der findes forskellige former for angstlidelser, der hver især tager navn efter, hvad barnet mest er bange for, og som beskriver, hvordan barnet reagerer på angsten, og hvordan det forsøger at undgå angsten.

De diagnostiske kriterier for angstlidelser er beskrevet i DSM 5 (det amerikanske diagnosesystem) [1] og i ICD 10 (WHO's diagnosesystem, der benyttes i Europa)[2]. For at opfylde kriterierne for en angstlidelse skal en række symptomer være til stede, og angsten skal i væsentlig grad gribe negativt ind i barnets liv. Symptomerne på og kriterierne for at få en angstdiagnose er i hovedsagen ens for børn og voksne. Den eneste angstdiagnose, der hidtil har været forbeholdt børn, er separationsangst diagnosen, men med indførelsen af DSM 5 i 2013, er det også blevet muligt for voksne at få en separationsangstdiagnose.

Diagnoser er kategoriske – det vil sige, at man enten har eller ikke har en diagnose. At stille en diagnose kan være hensigtsmæssig for at få et grundigt indtryk af et barns angstproblematik, for at vurdere sværhedsgraden af angsten i forbindelse med forskning, eller for at regulere hvem der har ret til et behandlingstilbud. I realiteten er en angstlidelse ikke en enten/eller tilstand, men dimensionel, det vil sige, at den kan være til stede i forskellige grader. Således kan børn med angst, som ikke opfylder kriterierne for en egentlig diagnose, alligevel være svært ramt af angsten, og kan have brug for hjælp til at tackle angsten.

I det følgende vil de mest almindelige typer af angst hos børn blive beskrevet.

Separationsangst.

Anders på 10 år sover hver nat på en madras i sine forældres soveværelse. Forældrene har de sidste par år prøvet at overtale Anders til at sove på sit eget værelse, men Anders bliver vred og græder voldsomt, så snart de bare bringer emnet på banen. Anders kunne egentlig godt tænke sig at have en ven på besøg til overnatning, men har aldrig prøvet det, fordi han sover i forældrenes soveværelse. Forældrene oplever, at det er helt umuligt at ændre på sovesituationen. Når Anders ligger alene i sin egen seng på værelset, får han mavepine og kvalme. Forældrene synes, det er svært at finde ud, hvad Anders egentlig er bange for. Han har på et tidspunkt fortalt, at han er bange for, at der kan ske noget forfærdeligt med forældrene, og at han også kan være bange for at blive kidnappet. Om dagen er Anders hele tiden på vagt, fordi han holder øje med sine forældre. Hvis en af forældrene går ud med skraldet eller ned på et værelse, går Anders efter dem og stiller forskellige spørgsmål, som en undskyldning for at være i nærheden af dem. Når Anders sidder i stuen og forældrene fx er i køkkenet, kalder Anders ofte på dem, så han er sikker på, at de er der. Anders er i det hele taget meget afhængig af at være i nærheden af en voksen. I skolen og i fritidsordningen er han hele tiden sammen med en lærer eller en pædagog og han kan fx ikke løbe ud på boldbanen med de andre børn i frikvartererne. Hvis læreren skal hente noget i timerne, går Anders med. Når det er frikvarter,

sidder Anders på skolens kontor hos sekretæren. Forældrene beskriver, at angsten griber mere og mere ind i Anders' liv. For en uge side var familien til et klassearrangement i skoven, hvor Anders kun kunne lege med de andre børn, så længe han kunne se sine forældre. I går ville han pludselig ikke længere cykle hjem fra skole.

Børn med separationsangst bekymrer sig om, at noget slemt skal ske med deres mor eller far eller med dem selv, når de ikke er sammen. De kan bekymre sig om, at forældrene/tilknytningspersoner bliver syge eller dør og har derfor behov for hele tiden at vide, hvor forældrene er. De kan også bekymre sig om, at der kunne ske noget med dem selv, fx at blive kidnappet, fare vild, eller komme ud for en ulykke, der kunne forhindre dem i at være sammen med deres forældre. Derfor vil børn med separationsangst ikke være væk fra deres forældre, vil f.eks. ikke gå i skole, sove hos en kammerat eller deltage i skolelejr. Det er også almindeligt at disse børn ikke vil sove alene på deres værelse eller bliver kede af det, hvis deres forældre skal i byen en aften. Ofte vil barnet ikke vige fra forælderen i hjemmet, og følger efter denne rundt i huset. Hvis barnet er adskilt fra forælderen, ringer det typisk ustandseligt for at få bekræftet, at der ikke er sket noget med forælderen. Børn med separationsangst får ofte somatiske symptomer som hovedpine, ondt i maven, kvalme eller opkastning, hvis det skal eller forventes at skulle være væk fra dets forældre. Separationsangst er en af de mest hyppige angstlidelser i barnealderen og er - foruden enkeltfobi -

den angstform, der kan opstå tidligst, ofte i 7-8 års alderen. Den kan dog også opstå senere i livet og i voksenalderen. Ofte kan problemerne udløses af, at barnet har oplevet forskellige former for stress, fx flytning, skoleskift, dødsfald i familien, eller har været på en udvidet ferie. En separationsangst udvikler sig ofte gradvist, fx fra urolig søvn og mareridt til at barnet vil sove i forældrenes seng, eller fra at barnet har det skidt om morgenen, når det skal i skole med lejlighedsvis fravær fra skolen, eskalerende til daglige skænderier om skolegang, og at barnet nægter at gå i skole.

Specifikke fobier

Et barn med en specifik fobi har en voldsom angst for en bestemt situation eller ting, som i realiteten ikke er særlig farlig. Barnet prøver desperat at undgå den ting eller situation, det er bange for, og angsten går ikke over af sig selv. De mest almindelige specifikke fobier hos børn er angst for forskellige dyr eller insekter (f.eks. hunde, edderkopper eller slanger), angst for højder og tordenvejr, for blod, skader på kroppen eller at blive stukket (indsprøjtninger), eller angst for specifikke situationer som at flyve, køre i bus eller elevatorer. Børn kan imidlertid udvikle specifikke fobier for nærmest uendeligt mange ting, såsom telefoner, aviser, at gå til frisør, vand etc. I modsætning til de fleste voksne med en specifik fobi er børn ofte ikke selv klar over, at deres angst er ekstrem eller urealistisk. En fobi kan udløses af en traumatisk hændelse, f.eks. at være blevet bidt af en hund, at have siddet fast i en elevator eller en voldsom me-

diedækning af et flyuheld, men ofte kan der ikke findes en særlig grund til, at fobien er opstået. En specifik fobi kan gribe voldsomt ind i et barns liv. For eksempel kan en hundefobi forhindre barnet i at besøge en bedsteforælder eller andre, der har hund, at gå uden for huset af frygt for at møde en hund, og at barnet bruger meget tid på at tænke på, hvad der kunne ske, hvis det møder en hund og bliver bidt. Specifikke fobier opstår ligesom separationsangst ofte allerede i 7-9 års alderen, og det er almindeligt at have flere fobier på en gang.

Socialangst (social fobi)

Emma på 12 har i det sidste halve år klaget mere og mere over hovedpine og mavesmerter. Forældrene beskriver, at det er værst om morgenen inden skoletid. Nogle dage kommer Emma slet ikke i skole, typisk på dage, hvor hun skal holde oplæg eller ikke kan undgå at sige noget i timerne. Forældrene beskriver, at Emma altid har været en tilbageholdende og lidt genert pige, men nu er det som om genertheden hæmmer hende mere. Emma bekymrer sig rigtig meget over, hvad andre tænker om hende. Hun er sikker på, at hun vil lave fejl under et oplæg, og at de andre i klassen vil grine af hende og tænke, at hun er dum. Emma er desuden overbevist om, at de andre i klassen efterfølgende vil drille hende med de fejl, hun kommer til at lave. Det er efterhånden ikke kun i timerne i skolen, at Emma undgår at sige noget. Når Emma er på cafe med sine forældre, får hun dem til at bestille sin mad, fordi hun er sikker på at snuble over ordene og kludre i det, og så vil tjeneren nok tænke, at hun er un-

derlig. Når Emma møder klassekammerater på vejen, siger hun aldrig hej som den første, men forsøger at gemme sig, så hun helt undgår at hilse. Hun vil heller ikke selv købe ind i butikker.

Børn og unge med socialangst er ofte sky og tilbagetrukne, og de bekymrer sig meget om og er bange for, hvad andre synes om dem. De undgår derfor mange sociale situationer såsom fødselsdage, fester, sportsbegivenheder, at købe ting i forretninger eller at svare en telefon, og de har ofte svært ved at etablere venskaber. Børn med socialfobi kan være bange for, at andre oplever dem som f.eks. dumme, kedelige, snavsede, skøre eller ikke værd at bryde sig om. De frygter, at de i situationer med andre mennesker enten vil optræde på måder eller vil vise symptomer på deres angst, som vil blive vurderet negativt af andre – at deres måde at være på vil være pinlig eller fløv. For at kunne sige at et barn har socialfobi, skal angsten for at andre oplever dem negativt ikke kun opstå sammen med voksne, men også sammen med jævnaldrende. Nogle børn med socialfobi frygter næsten alle sociale situationer, er bange for at møde eller snakke med nye mennesker, undgår kontakt med mennesker uden for den nære familie og har svært ved at komme i skole. Andre børn er hovedsageligt bange for situationer, der involverer præstationer, f.eks. at sige noget i klassen eller at skulle fremlægge noget for klassen. Socialfobi ses sjældent før 10 års alderen og er mest almindelig i teenagealderen. Ubehandlet er socialfobi ofte en kronisk, vedvarende tilstand, som kan have store negative konsekvenser for

den unges liv og i værste fald udvikle sig til misbrug og depression

Særligt for socialfobi til forskel fra andre angstlidelser er, at unge med socialfobi, på trods af at de for det meste ikke kan undgå kontakt med andre mennesker og derfor jævnligt bliver eksponeret for det, de er bange for, vedbliver med at frygte, at andre vurderer dem negativt. De urealistiske tanker, som karakteriserer en ung med socialfobi, synes meget vanskelige at korrigere, på trods af at den unge ofte indgår i sociale situationer, som fx at købe ind i en forretning, hvor den unges tanker om fx at være pinlig eller at blive vurderet negativt af ekspedienten, udefra betragtet kan forekomme helt absurd. En meget indflydelsesrig model for vedligeholdelsen af socialfobi [17] forklarer dette fænomen ved, at der er en række psykologiske processer på spil ved socialfobi, som forhindrer, at den unge får realitetskorrigeret sine urealistiske og uhensigtsmæssige tanker. For det første vender den unge i sociale situationer opmærksomheden indad i stedet for udad på samtalepartneren og bliver derved meget optaget af egne kropslige reaktioner og eget udseende. Derved forhindres den unge i at få et realistisk billede af samtalepartnerens vurdering af den unge, men bliver i stedet bekræftet i den unges egen negative selvopfattelse. For det andet benytter den unge med socialfobi sig af såkaldt sikkerhedsadfærd i sociale situationer, med det formål at undgå andres negative vurdering. Hvis den unge fx er bange for at komme til at rødme, fordi den unge tror, at andre vil vurdere dette som latterligt, bærer den unge altid halstørklæde sammen

med andre. Herved forhindres den unge i at få en realistisk erfaring med, hvordan andre vurderer rødmen. Endelig har unge med socialfobi en tendens til at lave såkaldt søforhør, det vil sige, at den unge før og efter sociale situationer gennemtænker situationen i detaljer med fokus på det negative ting, fx de fejl de har lavet, hvor dumme de har set ud, eller hvor meget de er blevet afvist. Disse særlige måder at tænke på, der er på spil for unge med socialfobi, forhindrer, at den unge lærer af sine erfaringer med interaktioner med andre mennesker.

Generaliseret angst

Mads på 10 år har siden børnehaveklassen haft mange bekymringer, som han har svært ved at stoppe. Forældrene beskriver, at Mads nærmest bekymrer sig om alt. Mads bekymrer sig fx meget om sin egen sundhed. Lige nu er Mads meget bange for, at han fejler noget alvorligt. Han er uhyre opmærksom på den mindste ændring i sine kropslige fornemmelser. Bekymringerne er taget til efter at en god vens storebror døde. Mads har mange fysiske symptomer som kvalme, følelse af uro, anspændthed, hjertebanken og hovedpine og har i perioder haft svært ved at synke. Mads er blevet undersøgt ved lægen som har konstateret, at der ikke er noget fysisk galt med Mads, men Mads tror ikke helt på lægen. Mads lægger meget bånd på sig selv i skolen og falder nærmest mentalt sammen, når han kommer hjem. Han kan spørge i en uendelighed hver dag: Hvad nu hvis, hvad tror du det er, hvordan kan du vide det, er det nu sikkert? Mads kan desuden have svært ved at glæde sig til

noget (fx ferie), fordi han kan være bekymret for, at alt muligt skal gå galt: Har vi råd til det? Kan vi finde vej? Hvad hvis jeg bliver syg? Kan vi nå noget? Mads har desuden meget svært ved at blive passet ude eller sove hos andre. Han er bekymret for, at han ikke kan falde i søvn, så han ikke får nok søvn. Hver nat sover Mads i forældrenes seng eller på en madras på gulvet. Forældrene tænder først for nyhederne i fjernsynet, når Mads sover, da nyhederne sætter mange bekymringer i gang. Mads er fx meget bekymret for terror og indbrud. Mads er en godt begavet dreng, der er vellidt blandt kammeraterne. Mads beskriver selv, at det er hårdt at være populær. Mads er fx bekymret for, om han bliver en ballademager af at lege med en dreng fra klassen, der ofte er fræk. Mads siger ofte, at hans liv vil være meget nemmere, hvis han ikke hele tiden bekymrede sig.

Børn med generaliseret angst er overdrevent bekymrede og har svært ved at kontrollere deres bekymringer. De bekymrer sig om mange forskellige områder af deres liv såsom skolen, konkurrencer, sport, familien, og nyt der skal ske. De har ofte fysiske symptomer som anspændthed, hovedpine, kvalme og diarré. Børn med generaliseret angst er ofte rastløse, har svært ved at slappe af, bliver let irritable, og kan have søvnforstyrrelser. Til forskel fra de mere afgrænsede bekymringer ved separationsangst og socialfobi kan bekymringerne hos børn med generaliseret angst ændre sig hele tiden, men handler for det meste om fremtidige farer. Ofte er børnene meget perfektionistiske og stiller høje krav til sig selv

om for eksempel at præstere godt i skolen. Børn med generaliseret angst søger ustandselig trøst og beroligelse hos forældrene og stiller spørgsmål om det, de er bange for, men forældrenes beroligelse hjælper dem ikke. Disse børn er også ofte triste. Generaliseret angst opstår typisk i 10-12 års alderen, og der er risiko for at ubehandlet generaliseret angst kan udvikle sig til tristhed og depression.

Som tidligere nævnt kan moderate bekymringer være adaptive og hjælpe et individ med at forberede sig på en kommende fare eller udfordring. Der findes forskellige bud på, hvordan de overdrevne og ukontrollerbare bekymringer, der er centrale for generaliseret angst, udvikles og vedligeholdes såvel hos voksne som hos børn [18]. Mennesker med generaliseret angst synes i særlig grad at have svært ved at udholde tvivl eller usikkerhed om, hvad der kan ske i fremtiden (på engelsk: "Intolerance of uncertainty"). For at undgå angsten og ubehaget forbundet hermed anvendes bekymringer, således at bekymringer bliver den foretrukne meststringsstrategi. Bekymringerne tjener således til at undgå at mærke angsten for, hvad der kunne ske og fungerer således som en slags undgåelsesadfærd. Samtidig udvikles der imidlertid også negative antagelser om bekymringerne, såkaldte type 2 bekymringer, eller bekymringer om bekymringer. Bekymringerne opleves som ukontrollerbare eller farlige. Denne type 2 bekymring kan føre til forskellige uhensigtsmæssige strategier. I et forsøg på at kontrollere bekymringerne kan børn med generaliseret angst forsøge at undgå situationer, der

kan give anledning til bekymringer eller hele tiden søge forsikringer fra andre (fx forældrene) om, at der ikke er grund til bekymring. Alternativt kan de forsøge at undertrykke de tanker, der kan give anledning til bekymring. Begge strategier er dog med til at vedligeholde bekymringerne.

OCD (tvangshandlinger og tvangstanker)
Børn med OCD (OCD er en forkortelse for obsessive kompulsive forstyrrelser) har tanker, ideer eller billeder, som igen og igen vender tilbage i deres hoved. De kan for eksempel konstant være bekymrede over bakterier, være optagede af at alt skal ligge pænt og ordentlig og på en ganske bestemt måde, at der skal ske katastrofer som alvorlig sygdom eller død hos dem selv eller deres nærmeste, eller at de kan gøre andre skade. Barnet er i de fleste tilfælde selv klar over, at tvangstanker er overdrevne eller urimelige. Barnet ved, at tankerne er dets egne, men oplever tankerne som pinefulde og uønskede. Udover at have tvangstanker gentager børn med OCD som regel tvangsmæssigt bestemte handlinger igen og igen, ofte over lange perioder. De kan for eksempel vaske hænder utallige gange og i et bestemt mønster, de kan føle sig tvunget til igen og igen at tjekke om hoveddøren er låst, de kan have trang til at tælle til et bestemt antal, eller de kan ordne og omordne deres ting på helt særlige måder inden de skal sove. Tvangshandlingers formål er at afværge, at tvangstanker går i opfyldelse eller at undgå angst og ubehag. Forældrene bliver ofte inddraget i barnets tvangssymptomer, for eksempel ved at skulle sige godnat på

en helt særlig måde eller at forsikre barnet om, at de har gjort tingene godt nok. OCD opstår typisk i 9-12 års alderen.

Især 2 typer af dysfunktionel tænkning synes at være karakteristisk for både voksne og børn med OCD [18]. 1) Mennesker med OCD antager, at de ubehagelige og påtrængende tanker de kan få (og som alle mennesker i øvrigt kan få), betyder, at de er ansvarlige for, at der kan ske skade på dem selv eller andre. De har en såkaldt overdreven ansvarsfølelse (på engelsk: "Inflated responsibility"). 2) Mennesker med OCD har en tendens til at tro, at hvis man tænker noget slemt eller ubehageligt, er det ensbetydende med eller moralsk lige så slemt som hvis man gør noget, eller at noget vil ske (på engelsk: "Thought-action fusion"). Hvis man fx tænker at ens forældre vil køre galt, er der større sandsynlighed for, at de rent faktisk kører galt. For begge typer af tænkning ses tvangshandlinger eller ritualerne som et forsøg på at neutralisere eller reducere de ubehagelige tanker.

Komorbiditet

Selvom man som vist ovenfor meningsfuldt kan skelne mellem forskellige typer af angst hos børn og unge, er det almindeligt, at børn kan være ramt af flere angstlidelser på en gang. Således har 40 % - 60 % af børn og unge mere end en angstlidelse, og mange børn med angstlidelser har andre komorbide (samtidigt tilstedeværende) lidelser som fx ADHD, autismespektrum forstyrrelser og depression [3]. Kognitiv adfærdsterapi kan hjælpe de fleste børn og unge med angstlidelser [5]. Før

behandlingen er det imidlertid vigtigt at lave en grundig udredning af barnet, både for at få tilstrækkelig viden om de vedligeholdende faktorer ved barnets angst, om hvilke typer af angst der plager barnet, og om der er komorbide lidelser hos barnet, der skal tages med i betragtning ved behandlingen.

Referencer

1. American Psychiatric Association 2013: Diagnostic and Statistical Manual of mental Disorders, 5 edn.
2. Bertelsen A: WHO ICD-10 - psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser - klassifikation og diagnostiske kriterier. København: Munksgaard; 2000.
3. Beesdo-Baum K, Knappe S: Developmental epidemiology of anxiety disorders. *Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America* 2012, 21(3):pp. 457-478
4. Rapee RM, Schniering CA, Hudson JL: Anxiety Disorders During Childhood and Adolescence: Origins and Treatment. *Annu Rev Clin Psychol* 2009, 5(3):311-341.
5. Sundhedsstyrelsen: National klinisk retningslinje for behandling af angst hos børn og unge - Sundhedsstyrelsen. 2016.
6. Ezpeleta L, Keeler G, Alaatin E, Costello EJ, Angold A: Epidemiology of psychiatric disability in childhood and adolescence. *Journal of Child Psychology and Psychiatry* 2001, 42(7):pp. 901-914
7. Boddien DH, Dirksen CD, Bogels SM: Societal burden of clinically anxious youth referred for treatment: a cost-of-illness study. *J Abnorm Child Psychol* 2008, 36(4):487-497.
8. Flachs EM EL, Koch MB., Ryd JT DE, Skov-Ettrup L, Juel K.: Sygdomsbyrden i Danmark – sygdomme. Statens Institut for Folkesundhed, Universitet S. København: Sundhedsstyrelsen; 2015.
9. Gregory AM, Caspi A, Moffitt TE, Koenen K, Eley TC, Poulton R: Juvenile mental health histories of adults with anxiety disorders. *The American Journal of Psychiatry* 2007, 164(2):pp. 301-308
10. Gregory AM, Eley TC: Genetic influences on anxiety in children: What we've learned and where we're heading. *Clinical Child and Family Psychology Review* 2007, 10(3):199-212.
11. Rapee RM, Kennedy SJ, Ingram M, Edwards SL, Sweeney L: Altering the Trajectory of Anxiety in At-Risk Young Children. *American Journal of Psychiatry* 2010, 167(12):1518-1525.
12. Creswell C, Murray L, Stacey J, Cooper P: Parenting and child anxiety. In: *Anxiety disorders in children and adolescents*. Edited by Silverman WK, Field AP, 2 edn. Cambridge: Cambridge University Press; 2011: 299-321.
13. Breinholst S, Esbjorn BH, Reinholdt-Dunne ML, Stallard P: CBT for the treatment of child anxiety disorders: A review of why parental involvement has not enhanced outcomes. *Journal of Anxiety Disorders* 2012, 26(3):416-424.
14. Murray L, Cooper P, Creswell C, Schofield E, Sack C: The effects of maternal social phobia on mother-infant interactions and infant social responsiveness. *Journal of Child Psychology and Psychiatry* 2007, 48(1):pp. 45-52
15. Bogels SM, Brechman-Toussaint ML: Family issues in child anxiety: attachment, family functioning, parental rearing and beliefs. *Clin Psychol Rev* 2006, 26(7):834-856.
16. Field AP, Hadwin JA, Lester KJ: Information processing biases in child and adolescent anxiety: a developmental perspective. In: *Anxiety disorders in children and adolescents*. Edited by Silverman WK, Field AP, 2 edn: Cambridge University Press.; 2011: 103-128.
17. Clark DM, Wells A: Chapter: A cognitive model of social phobia. In: *Social phobia: Diagnosis, assessment, and treatment*. New York, NY: Guilford Press; US; 1995: 69-93.
18. Cartwright-Hatton S, Reynolds S, Wilson: Adult models of anxiety. In: *Anxiety disorders in children and adolescents*. Edited by Silverstein JH, Field AP, 2 edn: Cambridge University Press; 2011: 129-160.